EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 81541
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 29-03-2024

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: CARLINA BELMAR BELMAR			RUN	: 7.121.363-3
F.Nac	: 02-02-1954	Edad	: 70 AÑOS, 1 MES	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-03-27	Fecha Egreso	: 29-03-2024	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J04.1-TRAQUEITIS AGUDA.

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1) Traqueitis aguda en tratamiento
2) HSA aneurismatica (2022)
3) HTA
4) Limitacion severa ABVD
5) Usuaria GGT
6) Usuaria TQT

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J04.1-TRAQUEITIS AGUDA. (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antec descritos, consulta en SU HSC el 26/03 por caudro de una semana de CEG, evaluada por ORL, se realiza cambio de canula, con presencia de secrecion purulenta, se deriva por sospecha de neumonia, se solicita TAC de torax, sin evidencia de focos de condensacion, se decide ingreso para terapia ATB por sospecha de traqueobronqutiis, se toma CBS;

Paciente estable dentro de su condicion, sin requerimiento de contencion, recibiendo alimentacion sin inconvenientes a traves de GGT, con saturaciones fluctuantes entre 90-94% estas ultimas 24 hrs, ambiental. COn requerimiento frecuente de aspiracion de secreciones. Pendiente resultado de CSB

TAC de torax -> Campos pulmonares bien expandidos, simetricos, sin focos de condensacion ni nodulos pulmonares

Ex de lab 28/03 -> Gb 10,5; plaq 450000, Hb/Hcto 12/36.2; segment 75%; proca 0,04, resto pendiente

Ex fisico -> Sopor superficial, apertura ocular frente a estumulo auditivo, de caracter parcial, mucosas rosadas, hidratadas, llene capilar < 2 segs
Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar MP (+) SRA
TQT correctamente posicionada, sin signos de infeccion cutanea circundante, de igual forma GGT
Extremidades anquilosadas, con hipotrofia muscular generalizada

PLAN DE MANEJO:

1) HDN. Estable, sin conflicto
2) Ventilatorio: Sat O2 fluctantes, sin requerimiento de apoyo por O2 suplementario
3) Infeccioso: Paciente actualmente cursando su dia N° 2 hospitalizado en contexto de traqueitis aguda, TAC de torax descarta focos de condensacion

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo semisentada 30°
2. Regimen fresubin a 30 cc/hr por GGT
3. Ceftriaxona 2 gr al dia EV
4. Ondansetron 8 mg EV SOS
5. Paracetamol 500 mg, 2 comp c/8hrs por GGT SOS
6. Levetiracetam 50 mg c/12 hrs por GGT
7. Amlodipino 10 mg al dia por GGT
8. Carvedilol 6,25 mg c/12 hrs por GGT
9. Bromuro de ipratropio 4 puff c/6hrs por AC
10. SAlmeterol 2 puff c/12 hrs por AC
11. KNT motora y respiratoria dos veces al dia
12. Aspiracion de secreciones SOS
13. Cuidados de enfermeria prevencion UPP
14. Examenes de control al terminar tratamiento

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO